

# Koło samooceny

Wizualizacja struktury samooceny — z czego czerpiesz wartość siebie. Klasyczne narzędzie Fairburna. W BN dominuje wycinek „waga/kształt” — cel: rozszerzenie innych obszarów.

**CZAS:** 30 min · narysuj koło · Sesja 8–10 CBT-E · powtarzaj co 4 tyg.

**ŹRÓDŁO:** Fairburn (2008, „Cognitive Behavior Therapy and Eating Disorders”)

## JAK UŻYWAĆ

Poznaj **typowy rozkład koła** u osób z bulimią i u osób bez (sekcja 1), zobacz **sześć kroków rysowania własnego koła** (sekcja 2). Sekcja 3 — Twój obecny i idealny rozkład. Sekcja 4 — plan rozszerzania.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Koło samooceny (*self-evaluation pie chart*) to **klasyczne narzędzie** wizualizacji *overvaluation*. Klient rysuje koło i dzieli je na wycinki odpowiadające temu, z czego czerpie samoocenę. Dla osoby z bulimią typowo: **60–80%** waga/kształt; zdrowa osoba bardziej zrównoważona. Koło używane jest na **trzy sposoby**: **(1)** diagnostycznie — unaocznia problem; **(2)** monitorująco — powtarzane co 4 tygodnie pokazuje postęp; **(3)** terapeutycznie — jako plan, w które obszary inwestować. Fairburn (2008): pacjenci, którzy rysują koło systematycznie i widzą zmianę proporcji, mają **znacząco wyższą** motywację do pracy z rdzeniem.

## 01 = Typowe rozkłady koła

### OSOBA Z BN

- **Waga / kształt: 60–80%**
- Kontrola jedzenia: 10%
- Praca / nauka: 5%
- Relacje: 3%
- Hobby: 1%
- Wartości: 1%

### OSOBA BEZ ED

- Waga / wygląd: 15–20%
- **Praca / nauka: 25–30%**
- **Relacje: 25%**
- Hobby / pasje: 15%
- Charakter: 10%
- Wartości / duchowość: 10%

**Klucz:** w bulimii cała wartość osoby *wisi* na jednym filarze — i dlatego każda jego fluktuacja jest tak destabilizująca. Osoba bez ED też dba o wygląd, ale to *jeden z obszarów*, nie centralny.

## 02 = Sześć kroków rysowania własnego koła

### 1 · NARYSUJ KOŁO

Duże, na czystej kartce. Wystarczy z ręki — nie musi być idealne.

### 2 · WYMIENŲ OBSZARY SAMOOCENY

Praca/nauka, relacje, hobby, zdrowie, charakter, wygląd/waga, wartości, kreatywność, duchowość.

### 3 · OBECNY ROZKŁAD

Podziel koło na wycinki proporcjonalnie do *obecnego* wpływu każdego obszaru na samoocenę. Bądź szczery/-a.

### 4 · IDEALNY ROZKŁAD

Narysuj drugie koło — jak *chciałbyś/chciałabyś*, żeby wyglądało. To Twój cel.

### 5 · PLAN ROZSZERZANIA

W które obszary chcesz *inwestować*, żeby zwiększyć ich wycinki? Konkretnie aktywności.

### 6 · MONITOROWANIE CO 4–6 TYG.

Powtarzaj rysowanie regularnie. Cel CBT-E: bardziej zrównoważony rozkład, żaden obszar nie dominuje (> 30%).

### 03 \ Moje koło — obecny i idealny rozkład

Wpisz **procentowo**, ile każdy obszar zajmuje obecnie w Twojej samoocenie, i ile chciałbyś/chciałabyś, żeby zajmował idealnie. Suma w każdej kolumnie = 100%.

| OBSZAR                                  | OBECNY %    | IDEALNY %   | CO MOGĘ ZROBIĆ, BY ZWIĘKSZYĆ |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Waga / kształt ciała                    |             |             |                              |
| Praca / nauka                           |             |             |                              |
| Relacje (rodzina, przyjaciele, partner) |             |             |                              |
| Hobby / pasje                           |             |             |                              |
| Charakter / wartości                    |             |             |                              |
| Inne (kreatywność, duchowość)           |             |             |                              |
| <b>SUMA</b>                             | <b>100%</b> | <b>100%</b> |                              |

### 04 \ Mój plan rozszerzania samooceny

**PIERWSZY OBSZAR, W KTÓRY CHCĘ ZAINWESTOWAĆ W NAJBLIŻSZYM MIESIĄCU**

— konkretna aktywność, częstotliwość, kontekst; mały krok, nie przewrót

**Klucz:** koło samooceny działa, bo *wizualizuje* to, co inaczej pozostaje abstrakcją. Większość pacjentów wie „w teorii”, że ich samoocena jest zbyt zależna od wagi — ale dopiero zobaczenie wycinka **70-80%** na kartce *uderza*. To moment, w którym wiele osób mówi: „*nie wiedziałem/-am, że to aż tyle*”. Fairburn (2008): koło jest **najprostszym narzędziem etapu 3**, ale też jednym z najskuteczniejszych w motywowaniu do pracy z rdzeniem. Powtarzanie co 4-6 tygodni daje *obiektywne dowody* postępu — wycinek „waga” zmniejsza się, inne rosną. To zmiana, której nie da się „*oszukać*” — nie można narysować innego koła, jeśli realnie zmiana się nie dokonała. **Po 3-6 miesiącach** systematycznej pracy w etapie 3 typowy rozkład pacjenta z remisją: waga 20-30%, praca/nauka 25%, relacje 25%, hobby 15%, charakter 10%. To *nie* oznacza obojętności wobec wagi — oznacza, że waga jest **jednym z obszarów**, nie jedynym. I to wystarczy, by cykl bulimii nie miał paliwa.